

31 기억력 저하

채점표 예시

병력 청취(주제 관련)		예	아니오	
언제부터 기억력 저하를 느꼈는지 질문하였다.				
기억력 저하가 서서히 진행되는지, 계단식으로 진행되는지 물어보았다.				
기억력이 떨어진 계기가 있는지 물어보았다.				
기억력 저하의 양상에 대해서 질문하였다(최근 기억과 과거 기억, 물건 이름, 길 찾기, 돈 계산, 성격 변화 등).				
기억장애에 대해서 본인이 느끼고 있는지 물어보았다.				
일상 생활에 얼마나 지장이 되는지 질문하였다.				
동반되는 정신과적 증상에 대해서 질문하였다(우울, 불안, 환각).				
동반되는 신체 증상에 대해서 질문하였다(손떨림, 보행장애, 배뇨장애, 추위 불내성).				
최종 학력에 대해서 질문하였다.				
병력 청취(기본)		예	아니오	
복용 중인 약물에 대해서 질문하였다.				
환자가 앓고 있거나 앓았던 질환(뇌졸중, 뇌수막염, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 포함)에 대해서 질문하였다.				
이전에 정신건강의학과 진료를 받아 본 적이 있는지 물어보았다.				
두부 외상력, 수술력에 대해서 질문하였다.				
음주력, 흡연력에 대해서 질문하였다.				
가족들 중 치매를 앓은 사람이 있는지 질문하였다.				
신체 진찰		잘함	보통	미흡
MMSE를 정확하게 시행하였다.				
갑상샘을 시진 및 촉진하였다.				

안구운동 및 안면근육운동을 확인하였다.			
사지운동 및 감각을 확인하였다.			
걸음걸이를 보고 보행장애가 있는지 확인하였다.			
[뇌졸중이 의심될 경우] 환자에게 숨을 참으라고 말하고 경동맥 청진을 하였다.			
신체 진찰(공통)	잘함	보통	미흡
신체 진찰 전 물, 소독용 알코올 중 하나를 이용하여 손을 씻었다.			
신체 진찰을 할 때 옷이나 가운을 필요한 만큼만 노출시켰다.			
시행할 신체 검진에 대해서 미리 설명하거나 또는 진찰 결과를 설명하였다.			
신체 진찰 과정이 불편을 초래하지 않았는지 점검하였다.			
환자 교육	잘함	보통	미흡
추정 진단에 대해서 설명하였다.			
기억력 저하가 생기는 원인과 기전에 대해서 설명하였다.			
원인 감별에 필요한 검사를 설명하였다.			
향후 치료에 대한 교육을 시행하였다.			
생활 습관 교정에 대해서 설명하였다.			
[MMSE 점수 낮을 시] 치매지원센터 및 사회복지사 방문 치료 등에 대해서 설명하였다.			
환자-의사 관계 문항(PPI)	잘함	보통	미흡
쉬운 용어, 개방형 질문, 1회 이상의 요약 등 환자가 알아듣기 쉽게 말하였다.			
말을 끊지 않고, 적절한 호응과 경청을 통해 환자의 말을 잘 들어 주었다.			

눈맞춤, 환자와의 거리, 자세, 목소리의 크기나 속도가 적당하여 환자와의 의사소통에 어려움이 없었다.			
용모가 단정하였고, 지나친 동의를 구하지 않고, 적절한 자기 소개를 하였으며, 지나친 희망과 경고를 주지 않아 환자가 신뢰 할 수 있는 의사로 받아들여졌다.			
적절한 공감 표현을 하였고, 사무적이지 않고, 반말조로 얘기하지 않아 환자에게 인간적인 의사로 느껴졌다.			

증례별 알고리즘

